

Evaluation – sujet 52 : méningites bactériennes et virales – 28.07.2025 – Pr A Toumi

Concernant la physiopathologie de la méningite :

- A. L'infection par voie hématogène est la voie de contamination la plus fréquente
- B. Les micro-organismes responsables de la méningite échappent aux phagocytes grâce à une capsule antiphagocytaire.
- C. Les cellules phagocytaires, nombreuses dans le LCR, peuvent inhiber la multiplication des germes
- D. Une méningite peut survenir suite à une spondylodiscite cervicale par inoculation directe
- E. Les méningites secondaires à une inoculation directe sont dues à des germes multi-résistants

Au cours des méningites graves, les lésions cérébrales sont secondaires à :

- A. Une diminution du débit sanguin cérébral
- B. Une diminution de la pression intracrânienne
- C. Un afflux de polynucléaires neutrophiles
- D. Une diminution de la perméabilité de la BHM
- E. Une inflammation vasculaire

Une méningite bactérienne récurrente peut être secondaire à :

- A. Une brèche ostéoméningée
- B. Un asplénisme
- C. Une infection par le VIH
- D. Un déficit en complément
- E. Un diabète

En Tunisie, une méningite bactérienne est à déclaration obligatoire si elle est secondaire:

- A. Au méningocoque
- B. Au pneumocoque
- C. A *Haemophilus influenzae*
- D. A *Listeria monocytogenes*
- E. Au streptocoque B

Devant une méningite survenant chez un enfant porteur d'un implant cochléaire, le germe à évoquer en premier lieu est :

- A. Le méningocoque
- B. Le pneumocoque
- C. *Haemophilus influenzae*
- D. *Staphylococcus aureus*
- E. *Pseudomonas aeruginosa*

Devant une méningite survenant dans un contexte post-traumatique immédiat, le germe à évoquer en premier lieu est :

- A. Le méningocoque
- B. Le pneumocoque
- C. *Haemophilus influenzae*
- D. *Staphylococcus aureus*
- E. *Pseudomonas aeruginosa*

Les deux principales bactéries responsables de méningites bactériennes chez l'adulte sont :

- A. Le méningocoque
- B. Le pneumocoque
- C. *Haemophilus influenzae*
- D. *Listeria monocytogenes*
- E. Le streptocoque B

Chez le sujet âgé, les bactéries habituellement responsables d'une méningite purulente sont :

- A. Le méningocoque
- B. Le pneumocoque
- C. *Mycobacterium tuberculosis*
- D. *Listeria monocytogenes*
- E. *Brucella melitensis*

Devant une méningite purulente, le pneumocoque est évoqué en cas :

- A. De présence d'un implant cochléaire
- B. D'asplénisme
- C. De présence de troubles de la conscience
- D. De début progressif
- E. D'alcoolisme

Chez un patient hospitalisé pour une méningite, *Listeria monocytogenes* est évoquée devant :

- A. Un âge inférieur à 50 ans
- B. Une grossesse
- C. Une corticothérapie au long cours
- D. Un myélome
- E. Un traumatisme crânien récent

Une méningite à méningocoque est évoquée devant :

- A. La survenue pendant l'été
- B. L'absence d'éruption cutanée purpurique
- C. L'absence de troubles de la conscience
- D. Une corticothérapie au long cours
- E. Un déficit en complément

Habituellement, le tableau clinique d'une méningite purulente se caractérise par :

- A. Une fièvre d'installation brutale
- B. L'absence d'une raideur de la nuque élimine le diagnostic
- C. Des vomissements en jet
- D. L'intensité des céphalées qui prédit la survenue de complications
- E. Une photophobie constante

La méningite bactérienne du sujet âgé se caractérise par :

- A. L'absence d'une raideur de la nuque
- B. L'absence de fièvre
- C. La fréquence d'un syndrome confusionnel
- D. La possibilité de troubles du comportement
- E. La fréquence élevée de *Listeria monocytogenes*

Une méningite aiguë de l'adulte est considérée grave en cas :

- A. D'une PA systolique à 80 mmHg
- B. D'un GCS à 14/15
- C. De présence d'une hémiparésie
- D. De présence d'un purpura
- E. De présence de marbrures

Devant une suspicion de méningite, la PL est contrindiquée en cas :

- A. De présence de convulsions
- B. D'un GCS à 12/15
- C. D'une PA systolique à 100 mmHg
- D. D'un taux de plaquettes à $75000/\text{mm}^3$
- E. De prise d'aspirine à dose préventive

Un patient consulte pour un syndrome méningé fébrile. La PL montre un liquide trouble, EB à 600/mm³ (PNN à 70%) ER à 5/mm³, une Pchie à 1,8 g/l, une Gchie à 2 mmol/l (Gmie à 10 mmol/l), lactates dans le LCR à 2,5 mmol/l. L'examen direct est négatif. Vous évoquez une origine bactérienne devant :

- A. Le nombre d'EB
- B. La Pchie à 1,8 g/l
- C. La Gchie à 2 mmol/l
- D. Le taux de lactates LCR à 2,5 mmol/l
- E. Le taux de PNN à 70%

L'examen direct du LCR montre des diplocoques GN. Vous suspectez :

- A. Le méningocoque
- B. Le pneumocoque
- C. *Haemophilus influenzae*
- D. *Listeria monocytogenes*
- E. Le streptocoque B

L'ED est négatif. Vous décidez de pratiquer une recherche des antigènes solubles. Cette technique est utile pour le diagnostic d'une méningite à :

- A. Méningocoque de type B
- B. Pneumocoque
- C. *Haemophilus influenzae*
- D. *Listeria monocytogenes*
- E. Le streptocoque B

Chez un patient consultant pour un syndrome méningé fébrile évoluant depuis 72 heures, n'ayant pas reçu d'antibiotiques, le PL permet d'éliminer une méningite bactérienne devant :

- A. Un LCR clair
- B. Un taux de lactates < 3,2 mmol/l
- C. Un LCR est hémorragique
- D. Une protéinorrhachie de 0,2 g/l
- E. Une culture du LCR négative

Une PL pratiquée devant la suspicion d'une méningite, montre un LCR clair, EB à 100/mm³ (PNN à 60%), Pchic à 0,9 g/l, ED négatif. Vous évoquez :

- A. Une méningite purulente
- B. Une méningite décapitée
- C. Une méningite puriforme aseptique
- D. Une méningite virale
- E. Une méningite suraiguë

La méningo-encéphalite herpétique :

- A. Est essentiellement secondaire à HSV 2
- B. Est habituellement de bon pronostic
- C. Est secondaire à une nécrose neuronale
- D. Peut se révéler par des troubles du comportement
- E. Se caractérise par l'absence d'anomalies sur la TDM cérébrale réalisée les premières 48 heures

Au cours du traitement des méningites, la corticothérapie :

- A. Doit être toujours débutée avant l'antibiothérapie
- B. N'est indiquée que dans les méningites à pneumocoque
- C. Réduit la survenue de surdité
- D. Réduit la mortalité
- E. Est administrée jusqu'à la fin du traitement antibiotique

La prévention de la méningite à méningocoque de l'adulte repose sur :

- A. La déclaration obligatoire
- B. La vaccination
- C. Une antibioprophylaxie prolongée
- D. Une antibioprophylaxie systématique de l'entourage
- E. Une antibioprophylaxie à débiter dans les 48 heures suivant le contact

Les antibiotiques recommandés dans la prévention de la méningite à méningocoque de l'adulte sont :

- A. La rifampicine
- B. Le cotrimoxazole
- C. La ciprofloxacine
- D. La ceftriaxone
- E. La pristnamycine

La prévention de la méningite à pneumocoque de l'adulte repose sur :

- A. La déclaration obligatoire
- B. La vaccination des sujets immunodéprimés
- C. Une antibioprophylaxie des cas contacts
- D. Une antibioprophylaxie en cas de persistance d'une brèche ostéo-durale
- E. Une antibioprophylaxie prolongée de l'entourage

Devant une méningite, la PL de contrôle :

- A. Est indiquée systématiquement à 72 heures d'antibiothérapie
- B. Est indiquée en cas de persistance de la fièvre à 72 heures d'antibiothérapie
- C. Est indiquée en cas d'apparition de troubles de la conscience
- D. Est indiquée en cas de méningite à pneumocoque
- E. Doit être toujours précédée par un scanner cérébral

Devant une méningite, les éléments de mauvais pronostic sont :

- A. Un âge > 2 ans
- B. La présence de convulsions
- C. Des céphalées intenses
- D. La présence d'un sepsis
- E. Les troubles de la conscience